

HoLEP (Enucleación con láser de holmio)

Información para el paciente · Cirugía con láser para una próstata agrandada de cualquier tamaño

WARWIKI

La HoLEP es una cirugía con láser para una próstata agrandada (HPB) que extirpa el tejido interno que obstruye a través de un cistoscopio, **sin incisión externa**. Su gran ventaja es que sirve para **cualquier tamaño de próstata**, incluso glándulas muy grandes que antes requerían cirugía abierta, con poco sangrado y resultados muy duraderos.

Acerca de este procedimiento

A través de un cistoscopio en la uretra, un **láser de holmio** separa toda la próstata interna (la parte que causa la obstrucción) de su cubierta externa, como sacar la fruta de su cáscara. El tejido liberado se empuja a la vejiga y se tritura y retira (**morcelación**). Como extirpa toda la parte obstructiva, los resultados son **duraderos** y rara vez se necesita un nuevo tratamiento.

Por qué elegir la HoLEP

- **Sirve para cualquier tamaño** de próstata, incluso las muy grandes
- **Poco sangrado** — suele ser apta para hombres con anticoagulantes
- Sonda por poco tiempo y un resultado duradero

Es una técnica especializada; los resultados son mejores con un cirujano experimentado.

APRENDA LOS TÉRMINOS

HoLEP

Enucleación de la próstata con láser de holmio.

HPB

Agrandamiento benigno (no canceroso) de la próstata.

Enucleación

Extraer toda la próstata interna de su cubierta externa.

Láser de holmio

El láser que separa y sella el tejido con poco sangrado.

Morcelación

Triturar el tejido liberado para poder retirarlo.

Eyacuación retrógrada

Orgasmo seco, un efecto común e inofensivo.

¿QUÉ CAMBIA DESPUÉS? La mayoría de los hombres logra un chorro fuerte y duradero. Como en otras cirugías de próstata, la **eyaculación retrógrada** (orgasmo seco) es común. Algunos hombres tienen urgencia temporal o algo de escape por esfuerzo en las primeras semanas, que casi siempre se recupera; los efectos graves sobre las erecciones o la incontinencia duradera son poco comunes.

Cómo prepararse

- Se hace con **anestesia general o espinal** — siga las indicaciones de ayuno y medicamentos.
- Primero, un **análisis de orina** para descartar infección.
- Organice quien lo lleve; prepárese para usar sonda poco tiempo.

Qué sucede y después

1. Estará dormido o adormecido; se administran antibióticos.
2. El láser enuclea la próstata interna, que luego se morcela y se retira.
3. Se coloca una sonda, que suele retirarse en **un día**; muchos vuelven a casa el mismo día o tras una noche.

Espere **orina con sangre** y algo de ardor o urgencia un par de semanas; haga ejercicios del suelo pélvico si se lo indican, y evite el esfuerzo y levantar peso.

Llame a su equipo o busque atención si tiene:

- **No puede orinar** tras retirar la sonda
- **Sangrado abundante o coágulos** que bloquean el flujo
- Fiebre o escalofríos
- Escape que no mejora en las primeras semanas

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La HoLEP usa un láser para extirpar toda la próstata interna obstructiva con un cistoscopio; sirve para **cualquier tamaño**, con poco sangrado y resultados duraderos.
2. Espere un chorro fuerte; la eyaculación seca (retrógrada) es común, y la urgencia o el escape inicial suelen recuperarse.
3. La sonda se usa poco tiempo. Llame si no puede orinar, sangra mucho o tiene fiebre.